

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Épistaxis

Conduite à tenir devant saignement de nez simple, en l'absence de traumatisme sévère ou d'instabilité.

Indications

- Saignement nasal antérieur isolé.
- État général conservé.
- Besoin de gestes simples d'hémostase.

Vérifications préalables

- Installer assis, tête penchée en avant.
- Faire moucher doucement si caillot visible puis compression.
- Vérifier anticoagulant/antiagrégant, HTA connue ou traumatisme.
- Évaluer abondance et durée du saignement.

Ne pas appliquer ce protocole

- Saignement très abondant ou postérieur suspect.
- Traumatisme facial important ou suspicion de fracture.
- Malaise, hypotension, trouble respiratoire.
- Échec de compression correctement réalisée.

Conduite à tenir

- Compression continue des ailes du nez 10 minutes minimum.
- Froid externe local si possible.
- Prévenir le médecin si récurrence, anticoagulants, antiagrégants ou HTA connue.
- Repos ; éviter mouchage et efforts après arrêt du saignement.

Surveillance et traçabilité

- Noter heure, durée, abondance, côté et mesures effectuées.
- Tracer anticoagulant éventuel et paramètres si utiles.
- Surveiller récurrence dans les heures suivantes.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide si persistance après compression, récurrence ou résident fragile anticoagulé.
- Appel 15 si hémorragie abondante, malaise, dyspnée, état de choc ou traumatisme sévère.

Mention de sécurité

Compression continue et correcte. Tête en avant, jamais en arrière.

Fait à :

Le : / /

Signature :